6. 2022N45 A 男，38 岁。胸痛、发热 3 天。既往糖尿病病史 5 年。查体：T 37.6℃，右下肺叩浊，呼吸音减低。胸片提示右侧胸腔积液。胸腔穿刺抽液化验显示：胸水 WBC 650×10⁶/L，其中淋巴细胞 90%，葡萄糖 3.2mmol/L，该患者最可能的诊断是

病程短 抵抗力差 低热

优先考虑肿瘤、结核←单个核为主

A.结核性胸膜炎 <3.3→渗出液

B.恶性胸腔积液 不能排除肿瘤,但题干完全符合结核→选结核

C.脓胸

D.类肺炎性胸腔积液

二者鉴别:脓胸特点(脓性、臭、pH<7、ADA>45)

胸腔/胸膜腔感染→引流+抗生素

又叫肺炎旁胸腔积液:肺炎、肺脓肿、支扩继发感染引起的胸水 ┬ 复杂性:细菌已经侵入胸膜腔 脓胸

└ 单纯性:反应性渗出,细菌没有进入胸膜腔

7.2022N70-72 A 男，46 岁。一小时前在练习举重突起杠铃时感左侧胸痛，不敢深呼吸，随即感气短、呼吸不畅，吸气时胸痛加重，心悸，不能活动，来院检查。既往体健。查体：R 22 次/分，BP 130/70mmHg，一般状况好，无发绀，左肺叩诊鼓音，呼吸音减低，心律整，心音减弱。

70.根据该患者目前检查结果，最可能的诊断是

A.肺栓塞

B.气胸

C.急性心肌梗死

D.胸腔积液

71.该患者还可能出现的体征是

A.气管向左侧偏移 气管右移

B.左胸可闻及胸膜摩擦音

C.左肺可闻及湿啰音 多无啰音

D.左胸语音震颤消失

72.该患者不可能出现的体征是

A.心尖搏动消失 1、心脏问题2、左侧大量气胸/胸腔积液、肺气肿影响心尖搏动触诊

B.肺动脉瓣区第二心音增强 破坏胸腔负压→肺血管变细→肺循环阻力↑→肺动脉高压→P2亢进

C.心界叩诊向左扩大 左侧气胸心界向右扩大

D.窦性心动过速 气胸→又吸气又吸血↓→回心血↓→前负荷↓→搏出量↓→动用心率储备维持心输出量

8.2023N68-69 A 男性，32 岁。因发热、盗汗、咳嗽伴右胸痛 2 周，气短不能平卧 3 天来诊。既往有肺结核病史。查体：T 37.8 度，P 96 次/分，R 20 次/分，BP 110/70mmHg。气管向左偏斜，右中下肺叩诊浊音，呼吸音消失，双肺未闻及干湿啰音，心律齐，心音正常，肝脾肋下未触及，双下肢无水肿。

68.最可能的诊断是

A.右下肺炎

B.右侧胸膜肥厚 结核引起的干性胸膜炎,纵隔应向患侧移位

C.肺栓塞

D.右侧胸腔积液 结核引起的湿性胸膜炎

69.为尽快缓解该患者症状，制定下一步诊治方案，应首选的检查是

A.胸部 B 超 B超引导下做胸穿

B.心电图

C.胸部 CT

D.CTPA